SENTENÇA

[Fornecimento de medicamentos]
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
0805355-39.2023.8.15.0751
AUTOR: ANA KAROLINE NASCIMENTO ARAUJO
REU: UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Visto etc.

TRATA-SE DE AÇÃO de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido Indenizatório e pleito de tutela de urgência ajuizada por **ANA KAROLINE NASCIMENTO ARAUJO**, já devidamente qualificada nos autos, em desfavor da operadora de plano de saúde **UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**, pessoa jurídica de direito privado também qualificada, objetivando o custeio integral e contínuo de terapia medicamentosa à base de fitocanabinoides.

A parte Autora narrou ser portadora de múltiplas enfermidades de natureza crônica e complexa, incluindo Enxaqueca (CID G43), Fibromialgia (CID M79.7), Dor Crônica (CID R52.1), Lúpus Eritematoso Sistêmico (CID M32.1), Diabetes Tipo 2 (CID E11) e Obesidade (CID E66), condições que têm comprometido de forma significativa sua qualidade de vida e capacidade funcional, conforme detalhado em laudo médico anexado.

Segundo a inicial, após a comprovação da ineficácia e dos graves efeitos colaterais resultantes dos tratamentos farmacológicos convencionais, que incluíram o uso de Ibuprofeno, Amitriptilina, Duloxetina, Pregabalina, Engality, Tramal, Azitioprina, Hidroxicloroquina, Melformina, Dulaglutida e Quetiapina, o médico assistente prescreveu o uso contínuo dos medicamentos *Bisaliv Power Full Spectrum 1:100* (CBD 20mg/ml, THC < 0,3%) e *Bisaliv Power Full Spectrum 20:1* (CBD 1mg/ml, THC 20mg/ml), ambos derivados de *Cannabis* e destinados a minimizar os sintomas álgicos, a fadiga persistente e os distúrbios do sono característicos de seu quadro clínico.

A despeito da prescrição médica fundamentada e da obtenção da Autorização de Importação Excepcional concedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com base na Resolução de Diretoria Colegiada -

RDC nº 660, de 30 de março de 2022, a operadora de saúde recusou-se administrativamente a cobrir os custos do tratamento, alegando a ausência de previsão dos fármacos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), razão pela qual a Autora pleiteou, em juízo, a tutela de urgência para o fornecimento imediato dos medicamentos, juntamente com a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O pedido de tutela de urgência foi deferido (ID 84833408), compelindo a Ré ao fornecimento dos medicamentos. Contra esta decisão, a Ré interpôs Agravo de Instrumento (ID 87345810). Em sede recursal, a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba proferiu acórdão (ID 108194046) dando provimento ao recurso da Unimed, reformando a decisão interlocutória e revogando a liminar, pautando o entendimento na natureza de *uso domiciliar* do fármaco pleiteado e na ausência de enquadramento nas exceções legais de cobertura.

A Ré, em sua Contestação (ID 91356511), alegou a licitude da negativa em função do caráter experimental (*off label*), da ausência de registro sanitário e do uso exclusivamente domiciliar dos medicamentos, defendendo a taxatividade do Rol da ANS, mesmo após a Lei nº 14.454/2022.

A Autora apresentou Réplica (ID 100362698), reiterando a urgência do tratamento, a solidariedade dos entes, a suficiência da autorização da ANVISA para fins de custeio e a abusividade da recusa.

É o relatório. DECIDO.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO

Dispõe o CPC, em seu artigo 355, inciso I, que é permitido ao Julgador apreciar antecipadamente o mérito, através de sentença com resolução de mérito, quando julgar desnecessária a produção de novas provas.

Desta feita, considerando que a causa já se encontra madura o suficiente para ser julgada, bem como em homenagem aos princípios da economia processual e da celeridade, é imperativo julgar antecipadamente o feito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

DA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE

Constata-se, pela análise dos autos, que a relação jurídica estabelecida entre as partes se traduz inequivocamente em **relação de consumo**, sendo aplicáveis, portanto, as disposições do **Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990)**. Trata-se de vínculo jurídico atinente ao mercado

de **prestação de serviços médico-hospitalares e suplementares de saúde**, no qual a autora figura como **consumidora e beneficiária** do plano contratado, e a ré, como **fornecedora de serviços**, na condição de operadora do plano de saúde.

O enquadramento jurídico decorre da **própria natureza do contrato de assistência à saúde**, que, embora disciplinado pela **Lei nº 9.656/98**, apresenta-se como típico contrato de **relação de consumo**, por inserir-se no contexto das atividades empresariais de fornecimento de serviços mediante remuneração.

Nesse panorama, o **artigo 2º** do **Código de Defesa do Consumidor** define como consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, enquanto o **artigo 3º, § 2º**, dispõe que serviço é toda atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária — categoria na qual se enquadram as **operadoras de planos de saúde**.

O entendimento jurisprudencial acerca da aplicação do **Código de Defesa do Consumidor** aos contratos de planos de saúde encontra-se **plenamente pacificado** no âmbito do **Superior Tribunal de Justiça**, conforme sedimentado em seus enunciados sumulares.

Com efeito, a **Súmula nº 469/STJ** estabelece que:

"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde."

De igual modo, a **Súmula nº 608/STJ** dispõe:

"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."

Tais enunciados consolidam a compreensão de que as operadoras de saúde, enquanto fornecedoras de serviços no mercado de consumo, submetem-se aos ditames protetivos da legislação consumerista, ressalvada apenas a hipótese de planos de autogestão.

Dessa forma, ainda que a matéria referente aos planos de saúde seja regulada pela **Lei nº 9.656/1998**, as normas do **Código de Defesa do Consumidor** incidem **de maneira supletiva e complementar**, especialmente no que concerne à **interpretação das cláusulas contratuais**, à **observância da boa-fé objetiva** e à **tutela da parte hipossuficiente**.

DO MÉRITO

A essência da presente demanda reside em determinar se a operadora de plano de saúde Unimed João Pessoa é obrigada a custear, de forma contínua e integral, os medicamentos *Bisaliv Power Full Spectrum 1:100* e *Bisaliv Power Full Spectrum 20:1*, ambos derivados de *Cannabis*, para o tratamento das múltiplas patologias crônicas que acometem a Autora.

A recusa administrativa da Ré fundamentou-se na alegação de ausência de previsão desses fármacos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, bem como na sua classificação como medicamentos de uso domiciliar, para os quais a cobertura seria, em regra, excluída.

A Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece, em seu art. 10, inciso VI, que **não é obrigatória a cobertura do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar**, ressalvado o disposto no art. 12, inciso I, alínea "c", do referido diploma legal.

No caso em análise, o medicamento *Bisaliv Power Full Spectrum* é classificado como de **uso exclusivamente domiciliar**, sendo administrado pelo próprio paciente ou por terceiros em ambiente externo à unidade de saúde (hospital, clínica ou ambulatório), **não se tratando de medicamento passível de administração tanto em ambiente domiciliar quanto hospitalar, tampouco configurando continuidade de tratamento iniciado em regime de internação hospitalar**.

Conforme a regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e a jurisprudência consolidada, a cobertura de medicamentos de uso domiciliar é obrigatória **apenas nas seguintes hipóteses excepcionais**, que **não se aplicam ao caso concreto**:

· **Quimioterapia oral (antineoplásicos orais)** – cobertura obrigatória desde a Lei nº 12.880/2013;

· **Home care (internação domiciliar)** – hipótese em que os medicamentos necessários devem ser custeados;

· **Medicamentos expressamente incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS** – cobertura obrigatória quando prevista para a respectiva indicação clínica.

Inserido nessa matéria, eis o entendimento jurisprudencial:

> "DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO . IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I – Caso em Exame: Ação de obrigação de fazer proposta por P. da S. D . e outro em face de Notre Dame Intermédica Saúde S/A, com o escopo de

obter o fornecimento de medicamento à base de canabidiol para tratamento de Transtorno do Espectro Autista e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade em criança. Sentença de improcedência, com condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Recurso interposto pela parte requerente, pleiteando a reforma da r. sentença, com o julgamento totalmente procedente da demanda, para condenar a Apelada ao fornecimento do medicamento **BISALIV POWER FULL 1:100** – CBD 20mg/ml, THC 0,3%, frasco de 30 ml, conforme prescrição médica, pelo tempo que se fizer necessário ao tratamento, com a fixação de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial . II – **Questão em Discussão: Discute-se a obrigatoriedade da operadora de plano de saúde em custear medicamento de uso domiciliar, não incluído no rol da ANS e sem registro na ANVISA. III – Razões de Decidir: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exclusão do custeio de medicamentos de uso domiciliar pelos planos de saúde, ressalvadas as hipóteses de exceção, como os antineoplásicos orais e os medicamentos de administração assistida. No caso concreto, o fármaco solicitado não se enquadra nas referidas exceções, sendo, portanto, legítima a negativa de cobertura por parte da operadora.** Aplicável à hipótese o Enunciado nº 40 desta C . 3ª Câmara. IV – Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. **É lícita a exclusão de custeio de medicamentos de uso domiciliar por planos de saúde, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas pela jurisprudência .** Ante o não provimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios devidos pela parte autora para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça concedida.". (v . 6824)

(TJ-SP - Apelação Cível: 10149604320238260161 Diadema, Relator.: Mário Chiuvite Júnior, Data de Julgamento: 13/03/2025, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2025)

Assim, considerando que o *Bisaliv Power Full Spectrum* **não se enquadra em nenhuma das exceções de cobertura obrigatória**, possui **uso exclusivamente domiciliar**, **não é administrado em ambiente hospitalar** e **não configura continuidade de tratamento de internação**, a operadora revela-se **legalmente desobrigada de custeá-lo**, à luz da legislação vigente e das cláusulas contratuais aplicáveis.

Na esteira desse raciocínio, a Nota Técnica nº 442547, elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS), acostada aos autos (ID 128818726), concluiu de forma "NÃO FAVORÁVEL" à solicitação da autora.

O parecer técnico destaca que os derivados de *Cannabis* não estão incorporados ao SUS ou à saúde suplementar para as patologias indicadas, e que a literatura científica atual demonstra benefício apenas "modesto e incerto", com evidências de baixa qualidade para fibromialgia e dor crônica.

Ainda que o NATJUS não vincule a decisão judicial, seu parecer técnico-científico demonstra que o tratamento pleiteado não possui, até o momento, a robustez de evidências que justifique sua imposição como cobertura obrigatória, especialmente diante de uma expressa exclusão legal. A autorização de importação concedida pela ANVISA, embora relevante, é um ato administrativo de caráter excepcional e individual, que visa permitir o acesso do paciente ao produto, mas não se confunde com o registro sanitário definitivo e não tem o condão de criar, por si só, uma obrigação de custeio para as operadoras de saúde, conforme estabelecido no Tema 990 do STJ.

Dessa forma, a recusa da ré em custear os medicamentos prescritos encontra amparo na legislação vigente (art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98), nas normas da ANS e na jurisprudência consolidada, configurando exercício regular de um direito.

DA AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL

A pretensão de indenização por danos morais formulada pela Autora não encontra amparo no presente caso.

A mera negativa de cobertura por plano de saúde, ainda que eventualmente considerada indevida, não acarreta, por si só, dano moral presumido (*in re ipsa*).

Para a configuração do dano moral, é imperiosa a demonstração de que a conduta da operadora de saúde extrapolou o mero inadimplemento contratual e gerou um abalo significativo aos direitos da personalidade do segurado, caracterizando dor, vexame, sofrimento ou humilhação que fuja à normalidade e cause desequilíbrio psicológico.

No caso em análise, a recusa da Unimed baseou-se em interpretações da legislação e da regulamentação setorial que, embora contestadas, não podem ser consideradas manifestamente ilegais ou abusivas a ponto de, por si, gerarem um dano moral.

A conduta da Ré, ao negar o custeio, esteve pautada em dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais que excluem a obrigatoriedade de cobertura para medicamentos de uso domiciliar não registrados formalmente e não incluídos nas exceções do rol da ANS.

A ausência de prova de que a negativa de cobertura tenha causado à Autora um sofrimento excepcional, distinto dos aborrecimentos e dissabores inerentes a qualquer litígio contratual, inviabiliza o reconhecimento do dano moral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e por tudo o mais que dos autos consta, **JULGO IMPROCEDENTE** o pedido de obrigação de fazer formulado pela Autora, para que a Ré custeie os medicamentos *Bisaliv Power Full Spectrum 1:100* (CBD 20mg/ml, THC < 0,3%) e *Bisaliv Power Full Spectrum 20:1* (CBD 1mg/ml, THC 20mg/ml).

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

CONDENO a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade da justiça concedida à Autora.

Interpostos embargos declaratórios, intime a parte embargada para, querendo, oferecer contrarrazões.

Em caso de recurso de apelação, intime-se a parte contrária para contrarrazoar, caso tenha integrado a lide, e após remetam-se os autos ao E. TJPB, independente de nova conclusão.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publicado e registrado eletronicamente. Intimem-se

João Pessoa - PB , datado e assinado eletronicamente.
Luciana Celle G. de Morais Rodrigues
Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: LUCIANA CELLE GOMES DE MORAIS RODRIGUES
07/01/2026 16:20:00
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 131076341

26010716195989200000012

IMPRIMIR GERAR PDF